அட்டவணை 12.2: தோலில் காணப்படும் பாக்டீரியா தொற்று நோய்கள்

நோய்	நோய்க் கிருமி	நோயின் அறிகுறிகள்	பரவும் முறை
செல்லுலைடிஸ் (Cellulitis)	*ஸ்ட்ரெப்டோ காக்கஸ் பையோஜீன்ஸ்*	டெர்மிஸ் ஹைப்போ டெர்மிஸ் பகுதிகளின் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் வீக்கம் தோல் சிவப்பாகவும் இளஞ்சூடாகவும் தொடும்பொழுது வலியுடன் காணப்படும்	வெட்டுக் காயம் அல்லது சிராய்ப்பு மூலம்
செஞ்சருமம் அக்கி (Erysipelas)	*ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் பையோஜீன்ஸ்*	தோலில் அழற்சி மற்றும் புடைத்த தோல் திட்டு பெரும்பாலும் முகத்தில் காணப்படும். சில வேளைகளில் சீழ்பிடித்தும் காணப்படும்.	வெட்டுக் காயம் அல்லது சீராய்ப்பு
செஞ்சொறி(Impetigo)	*ஸ்டெபைலோ காக்கஸ் ஆரியஸ் ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் பயோஜீன்ஸ்*	சில வேளைகளில் கொப்புளம், சீழ் கொப்புளங்கள் வாய் மற்றும் மூக்குப் பகுதியில் குமிழிகள் காணப்படும்	தொடர்பினால் தொற்றும் தன்மையுடையது
காயங்கள் மூலம் தொற்றுகள்	*சூடோமோனஸ் ஏரோஜினோசா*	புண்களின் உள்ளே அல்லது வெளியே உயிர் மென்படலம் (Biofilm) உருவாதல்	சுற்றுச்சூழலில் காணப்படும் நுண்ணுயிரிகளக்கு புண்ணை வெளிப்படுத்துதல் மூலம், புண்ணை சுகாதாரமற்ற நிலையில் வைத்திருத்தல் மூலம்

மூக்கில் காணப்படும் சிறு முடிகள், காற்றில் உள்ள தூசிகளை வடிகட்டுகின்றது. மூக்கில் உள் பகுதி – சளிச்சவ்வால் (உறையால்) சூழப்பட்டுள்ளது. அதில் அதிகமாக(Mucus) சளியை சுரக்கும் செல்கள் மற்றும் குறு இழைகள் (Cilia) காணப்படுகின்றன. தொண்டையின் மேற்புறமானது குறு இழை கொண்ட சளி சவ்வை கொண்டுள்ளது. உட்சுவாசித்த காற்றை சளியானது ஈரமாக்கி, தூசிகளையும் நுண்ணுயிரிகளையும் பிடித்துக்கொள்கின்றது. இந்த துகள்கள் குறு இழைகளின் உதவினால் வாய் நோக்கி நகர்ந்து அகற்றப்படுகின்றது.

12.3.1 சுவாசப்பாதையின் அமைப்பு

சுவாசப்பாதை அமைப்பானது, மேல் சுவாசப்பாதையாகவும் (URT) கீழ் சுவாசப்பாதையாகவும் (LRT) இரண்டு முக்கியப் பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

வாய், மூக்கு, நாசியறை, சைனஸ், தொண்டை, எபிகிளாட்டிஸ் மற்றும் குரல்வளை முதலியவை மேல் சுவாசப்பாதை எனவும், மூச்சுக்குழல், முதல் நிலை மூச்சு கிளைக்குழல், மூச்சு நுண்குழல், நுரையீரல் மற்றும் காற்று நுண்ணறை கீழ் சுவாசப்பாதை என பிரிக்கப்படுகின்றது (படம் 12.9).

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 192 19-02-2019 5.53.43 PM